体检编号：0931212603303084

瑞慈健康体检 体检报告书

姓 名：	张敬峥	
性 别：	男	
检查日期：	2026-03-30	
年 龄：	28	
身 份 证：	50010119970409043X	
工作单位：	帆软软件有限公司	
部门：		
工号：		
职业：		

健康问卷

项目名称	检查结果
既往史(外)	无特殊
手术史名称	无特殊
外伤史部位	无特殊
过敏	无特殊

检查医师：郭祚金

一般检查		历史检查结果
项目名称	检查结果	2024年07月
身高	179.0 cm	178.0
体重	77.2 kg	69.9
体重指数BMI	24.1	22.1
收缩压	115 mmHg	102
舒张压	69 mmHg	57

检查者：宋惠玲

内科		历史检查结果
项目名称	检查结果	2024年07月
营养	营养良好	营养良好
面容	正常	正常
心率	72 次/分	68

心律	齐	齐
心音	正常	正常
心脏杂音	无	无
肺部	两肺呼吸音正常	两肺呼吸音正常
腹部	未见异常	未见异常
肝脏	肋下未及	肋下未及
脾脏	肋下未及	肋下未及
		检查医师：温利平

外科		历史检查结果
项目名称	检查结果	2024年07月
皮肤	未见异常	未见异常
浅表淋巴结	未见异常	未见异常
甲状腺	未见异常	未见异常
乳房	未见异常	未见异常
脊柱	未见异常	未见异常
四肢关节	未见异常	未见异常
		检查医师：郭祚金

眼科		历史检查结果
项目名称	检查结果	2024年07月
戴镜视力右	0.9	1.0
戴镜视力左	1.0	1.0
外眼检查	未见异常	未见异常
眼底检查	未见明显异常	未见明显异常
裂隙灯检查	未见异常	未见异常
科室小结	戴镜视力右值偏低(0.9)(参考值1~2)	
		检查医师：令敬恭

耳鼻喉		历史检查结果
项目名称	检查结果	2024年07月
耳	未见异常	未见异常
鼻	未见异常	未见异常
口咽	咽炎	慢性咽炎
科室小结	咽炎	慢性咽炎
		检查医师：夏萍

综合报告单

检验项目：尿常规					历史检查结果
项目名称	结果	参考值	单位	标志	2024年07月
尿胆原	阴性	阴性			阴性
胆红素	阴性	阴性			阴性

尿酮体	阴性	阴性			阴性
隐血	阴性	阴性			阴性
尿蛋白	阴性	阴性			阴性
亚硝酸盐	阴性	阴性			阴性
尿白细胞	阴性	阴性			阴性
尿糖	阴性	阴性			阴性
尿比重	1.030	1.005-1.030			1.030 (1.003-1.030)
酸碱度	6.00	5.0-9.0			6.50 (5.4-8.4)
维生素C	阴性	阴性			阴性
镜检白细胞	0	0-5	Cell/HP		0
镜检红细胞	0	0-3	Cell/HP		0
镜检管型	0	0	Cast/LP		0
镜检结晶	未见	未见	-		未见

审核者：赵钰菁　检查者：刘晶晶　　检验时间：2026-03-30 10:31:01

检验项目：免疫					历史检查结果
项目名称	结果	参考值	单位	标志	2024年07月
乙型肝炎表面抗原(HBsAg)	阴性	阴性			阴性

审核者：赵凤明　检查者：周雪　　检验时间：2026-03-31 03:47:07

检验项目：多肿瘤标志物				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
甲胎蛋白(AFP)(发光法-定量)	2.65	0.00-7.00	ng/mL	
癌胚抗原(CEA)(发光法-定量)	2.01	0.00-5.00	ng/mL	
糖类抗原19-9测定(CA19-9)	6.14	0.00-37.00	U/mL	
前列腺特异性抗原	0.52	0.00-4.00	ng/mL	
游离前列腺特异性抗原	0.21	0.00-0.75	ng/mL	
f-PSA/T-PSA	0.40	0.19-1.00	/	

审核者：唐红　检查者：王道芝　　检验时间：2026-03-31 03:46:28

检验项目：生化-肝功					历史检查结果
项目名称	结果	参考值	单位	标志	2024年07月
血清总胆红素	12.1	0-26	μmol/L		32.17 μmol/L (2--20.4)
血清直接胆红素	4.4	0.0-8.0	μmol/L		
血清间接胆红素	7.7	0.0-12.1	μmol/L		
血清总蛋白	71.5	65.0-85.0	g/L		68.78
血清白蛋白	45.4	40.0-55.0	g/L		44.48
血清球蛋白	26.1	20.0-40.0	g/L		24.30

白蛋白/球蛋白	1.74	1.20-2.40			1.83
血清丙氨酸氨基转移酶	28	9-50	U/L		16.10 U/L (0--40)
血清天冬氨酸氨基转移酶	19	15-40	U/L		
谷草/谷丙	0.68	/			
血清碱性磷酸酶	63	45-125	U/L		68.60 U/L (46--134)
血清γ-谷氨酰基转移酶	22	10-60	U/L		

审核者：彭紫微　检查者：尹琴　　检验时间：2026-03-31 04:09:14

检验项目：生化-肾功					历史检查结果
项目名称	结果	参考值	单位	标志	2024年07月
血清尿素	5.9	3.1-8.0	mmol/L		7.36 mmol/L (1.7--8.3)
血清肌酐	85	57-97	μmol/L		89.20 μmol/L (44.2--106.1)
血清尿酸	349	208-428	μmol/L		341.00 μmol/L (202--416)

审核者：彭紫微　检查者：尹琴　　检验时间：2026-03-31 04:09:14

检验项目：生化-血糖					历史检查结果
项目名称	结果	参考值	单位	标志	2024年07月
空腹血糖	4.45	3.90-6.10	mmol/L		4.48

审核者：彭紫微　检查者：尹琴　　检验时间：2026-03-31 04:09:14

检验项目：生化-血脂					历史检查结果
项目名称	结果	参考值	单位	标志	2024年07月
总胆固醇	6.03	<5.18	mmol/L	↑	4.87
甘油三酯	1.86	<1.70	mmol/L	↑	0.75
高密度脂蛋白胆固醇	1.20	>1.04	mmol/L		1.41 mmol/L (0.9--2.19)
低密度脂蛋白胆固醇	3.42	<3.37	mmol/L	↑	2.82
动脉硬化指数（AI）	4.03	<4.00		↑	2.45

审核者：彭紫微　检查者：尹琴　　检验时间：2026-03-31 04:09:14

检验项目：血常规五分类					历史检查结果
项目名称	结果	参考值	单位	标志	2024年07月
白细胞	7.15	3.5-9.5	*10^9/L		8.310

中性粒细胞百分比	45.90	40-75	%		46.00 % (50-70)
淋巴细胞百分比	48.00	20-50	%		48.50 % (20-40)
单核细胞百分比	4.60	3.0-8.0	%		4.70
嗜酸性粒细胞百分比	1.10	0.4-8	%		0.60 % (0.5-5)
嗜碱性粒细胞百分比	0.40	0-1	%		0.20
中性粒细胞数	3.28	1.8-6.3	*10^9/L		3.82 *10^9/L (2-7)
淋巴细胞数	3.43	1.1-3.2	*10^9/L	↑	4.03 *10^9/L (0.8-4)
单核细胞数	0.33	0.1-0.6	*10^9/L		0.39 *10^9/L (0.12-0.8)
嗜酸性粒细胞数	0.080	0.02-0.52	*10^9/L		0.05 *10^9/L (0.05-0.5)
嗜碱性粒细胞数	0.030	0-0.06	*10^9/L		0.02 *10^9/L (0-0.1)
红细胞	5.40	4.3-5.8	*10^12/L		4.84
血红蛋白	172	130-175	g/L		149
红细胞压积	0.501	0.40-0.50	L/L	↑	46.500 % (40-50)
平均红细胞体积	92.78	82-100	fL		96.1
平均血红蛋白量	31.85	27-34	pg		30.8
平均血红蛋白浓度	343.31	316-354	g/L		320
红细胞分布宽度-SD	45.1	21-52	fL		45.6
血小板	210.00	125-350	*10^9/L		224
血小板平均体积	9.200	9-13	fL		9.0 fL (6-13)
血小板分布宽度	15.6	9-17	fL		15.4
血小板压积	0.19	0.108-0.374	%		0.20 % (0-2.9)

审核者：赵钰菁　检查者：刘晶晶　　检验时间：2026-03-30 10:47:00

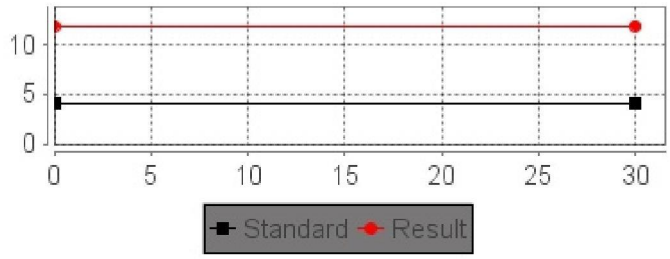
呼气试验

项目名称	检查结果
C13呼气试验(HP)	C13呼气试验(HP)阳性
影像报告	

成都高新瑞慈瑞高体检门诊部

^{13}C呼气试验Hp检验报告

个人信息		
姓名:张敬峥	性别:男	年龄:28
体检号:0931212603303084	检验日期: 2026-03-30	机器型号:HY-IREXBplus
试剂名称: ^{13}C尿素	纯度: 99%	电话:028-67568096
地址:成都市武侯区高新区益州大道599号7楼		
检验结果		
指标: DOB值	检测值: 11.98	结果: 阳性(+)
检验标准		
DOB<4.0 为阴性 DOB≥4.0为阳性		
图形分析		



结果评价

^{13}C呼气试验Hp检验报告结果: 阳性.

医生建议:请结合临床，定期复查，必要时抗幽门螺杆菌治疗并消化专科随访.

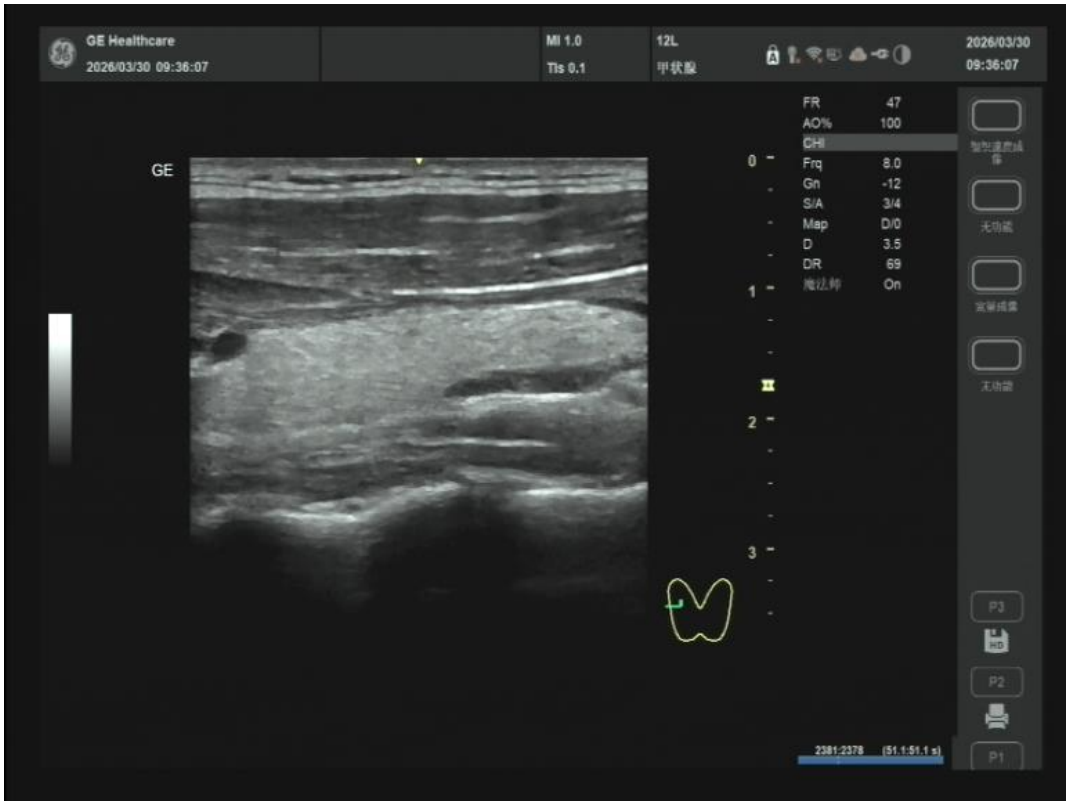
温馨提示:
*阳性表明存在HP感染,但DOB值介于4-6的结果为阳性灰区,如无明显临床指征,可以不做治疗处理。

检验人员: 刘晶晶 审核人: 赵钰菁

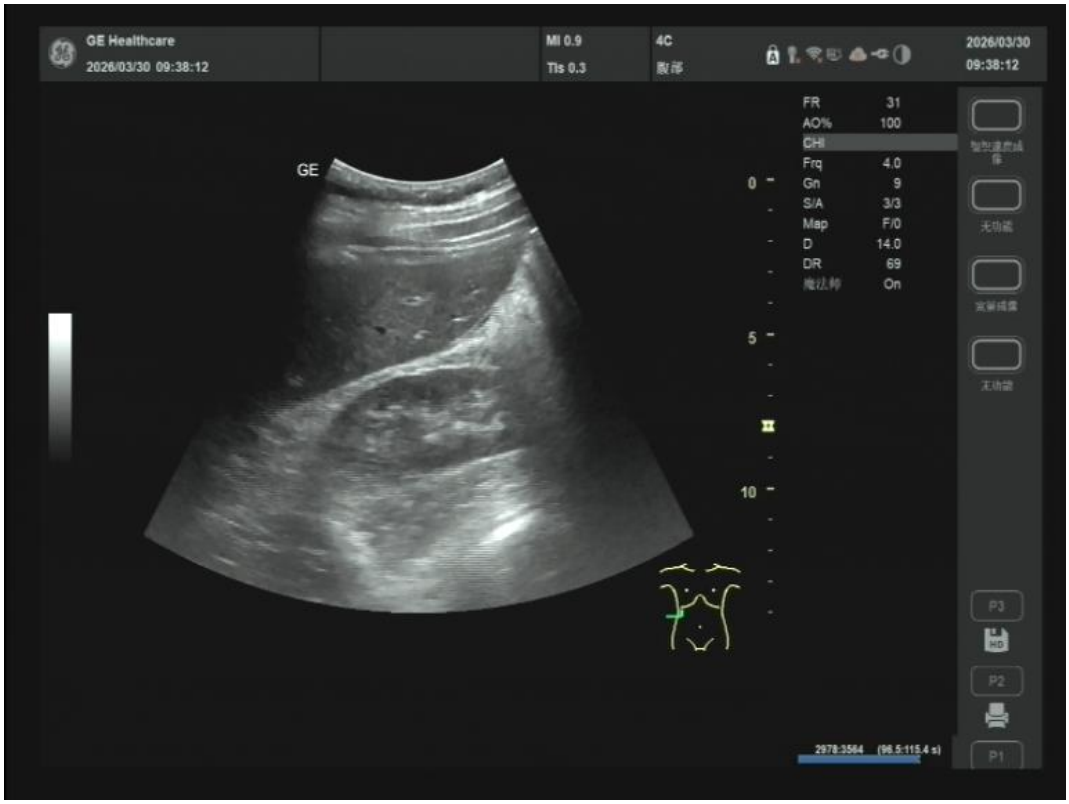
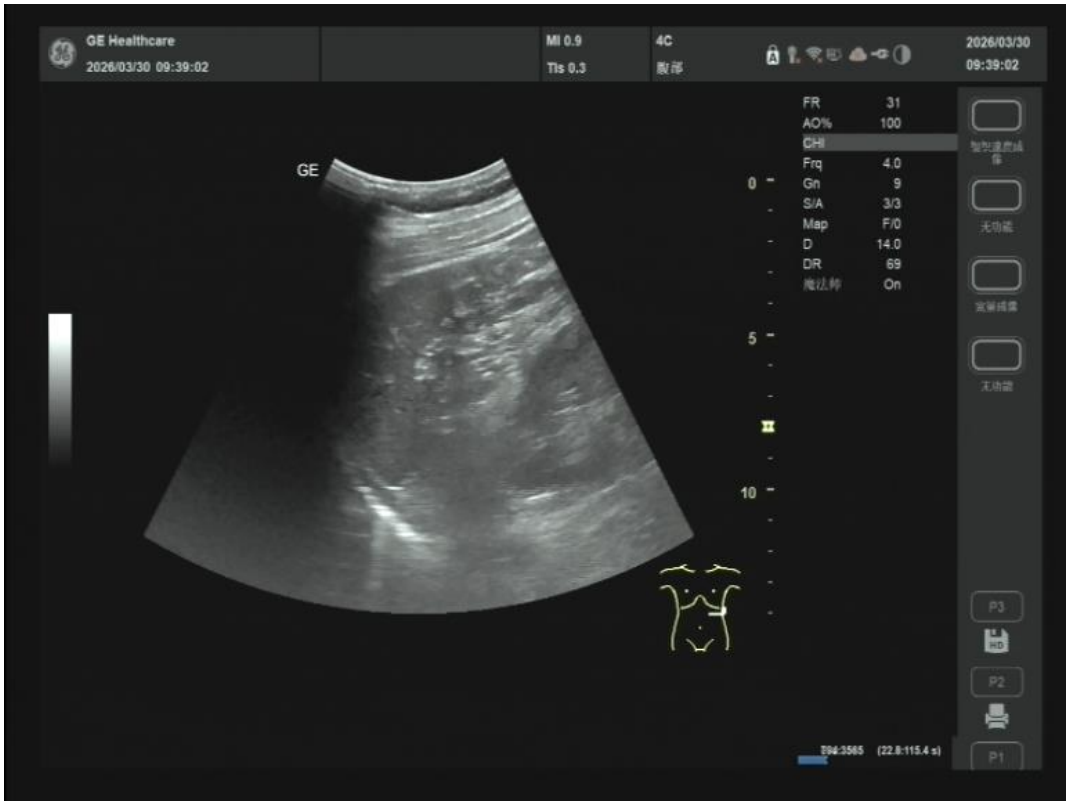
本报告只对本次检验负责

彩超室

项目名称	检查结果

检查描述	超声条件及图像质量【乙】 肝脏形态大小正常，包膜完整，肝内回声细密，分布尚均匀，血管纹理欠清晰。CDFI：未见明显异常血流信号。 胆囊大小正常范围，胆汁透声尚可，囊壁稍毛糙，胆囊腔内未见明显异常回声。胆总管近端未见扩张。 胰腺形态大小正常，内部回声均匀，主胰管未见扩张。CDFI：未见明显异常血流信号。 脾脏形态大小正常，包膜完整，内部回声均匀。CDFI：未见明显异常血流信号。 双肾形态大小正常范围，包膜光滑，集合系统未见明显分离。CDFI：血流灌注良好。 前列腺大小正常，包膜完整，内部回声均匀，其内未见明显异常回声。 双叶甲状腺形态大小正常，峡部厚度正常，包膜完整，内部回声均匀。CDFI：未见明显异常血流信号。
检查结论	肝内脂肪浸润 胆囊壁稍毛糙 胰、脾、肾目前未见明显占位性病变 前列腺未见明显异常 双叶甲状腺未见明显异常
影像附件1	

影像附件2	GE Healthcare 2026/03/30 09:36:56 MI 0.9 TIs 0.3 4C 腹部 2026/03/30 09:36:56 FR 31 AO% 100 CHI Frq 4.0 Gn 9 S/A 3/3 Map F/0 D 14.0 DR 69 On GE 0 5 10 P3 P2 P1
影像附件3	GE Healthcare 2026/03/30 09:37:04 MI 0.9 TIs 0.3 4C 腹部 2026/03/30 09:37:04 FR 31 AO% 100 CHI Frq 4.0 Gn 9 S/A 3/3 Map F/0 D 14.0 DR 69 On GE 0 5 10 P3 P2 P1

影像附件4	 GE Healthcare 2026/03/30 09:38:12 MI 0.9 TIs 0.3 4C 腹部 2026/03/30 09:38:12 GE FR 31 AO% 100 CHI Frq 4.0 Gn 9 S/A 3/3 Map F/0 D 14.0 DR 69 魔法师 On 0 5 10 P3 P2 P1
影像附件5	 GE Healthcare 2026/03/30 09:39:02 MI 0.9 TIs 0.3 4C 腹部 2026/03/30 09:39:02 GE FR 31 AO% 100 CHI Frq 4.0 Gn 9 S/A 3/3 Map F/0 D 14.0 DR 69 魔法师 On 0 5 10 P3 P2 P1

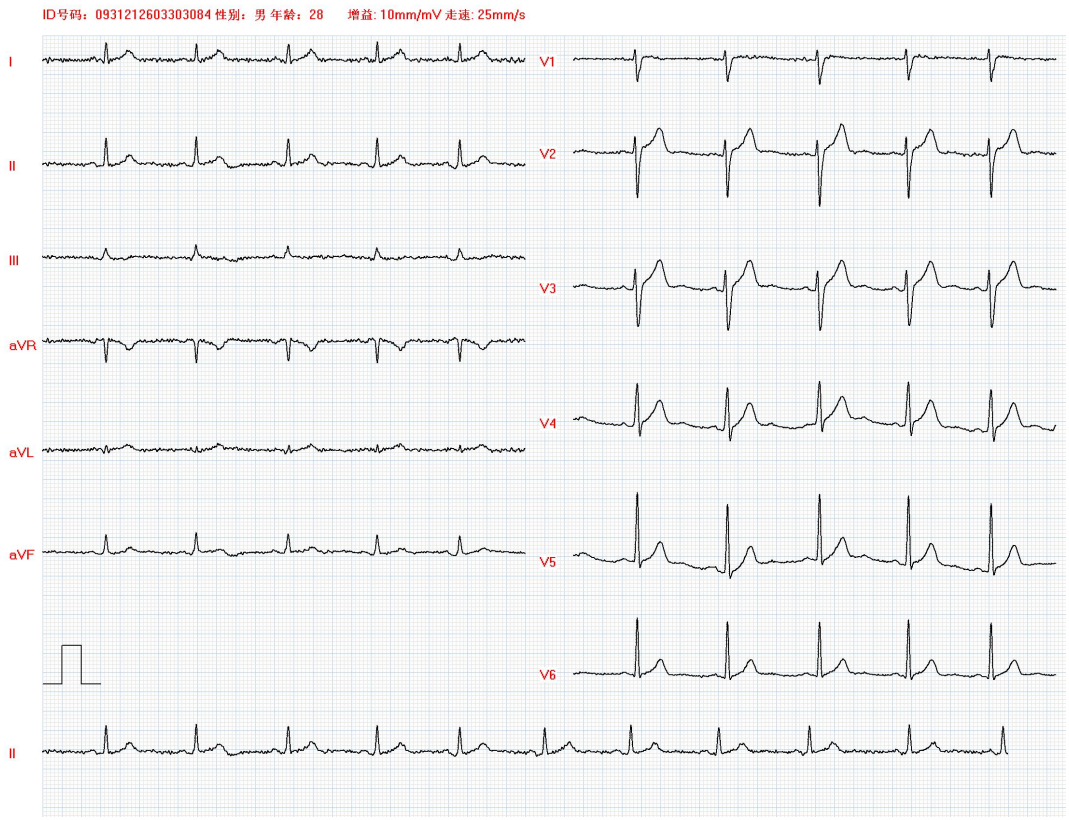
影像附件6	
2024年07月	1.胆囊壁稍毛糙 2.肝、胰、脾、双肾目前未见明显占位性病变 3.双叶甲状腺未见明显异常 4.前列腺未见明显异常
	诊断医师：肖萍

CT室

项目名称	检查结果
检查描述	胸廓对称，两肺纹理清晰，肺纹理走行自然，肺窗薄层示左肺上叶（IM82）见斑点状高密度影，长径约3mm。气管及诸叶、段支气管通畅。纵隔窗示纵隔居中，纵隔内未见明显肿大淋巴结，两侧胸腔未见明显积液征象。心脏形态、大小未见明显异常。两侧胸膜局部增厚。
检查结论	左肺上叶微小结节待除外，随诊复查。 两侧胸膜局部增厚。
2024年07月	右肺下叶小结节影，建议随诊复查。 右肺上叶钙化灶。
	审核医师：杨加军　诊断医师：张亮亮

心电图

项目名称	检查结果
检查描述	增益: 10mm/mV 走速: 25mm/s 心率: 64 bpm PR间期: 142 ms QRS时限: 96 ms QT间期: 390 ms QTC间期: 397 ms P电轴: 57 Angle QRS电轴: 57 Angle T电轴: 39 Angle RV5: 1.735 mV SV1: 0.585 mV
检查结论	窦性心律不齐

影像附件1	
2024年07月	窦性心律 正常心电图

诊断医师：季婷婷

终检结论

1.超重。体重指数BMI值偏高(24.1)(参考值18.5~23.9)。建议合理膳食、强度适中的运动，控制体重。
【超重与肥胖】体重超标包括超重与肥胖。体重指数（BMI）=体重（kg）/身高（m）的平方，BMI≥24为超重，BMI≥28为肥胖；男性腰围≥90cm和女性腰围≥85cm为腹型肥胖。体重超标是一种由多因素（如遗传、进食油脂较多、运动少、疾病等）引起的慢性代谢性疾病，尤其是肥胖，已经被世界卫生组织列为导致疾病负担的十大危险因素之一。建议：采取综合措施预防和控制体重，积极改变生活方式，宜低脂、低糖、高纤维素膳食，多食果蔬及菌藻类食物，增加有氧运动。若有相关疾病（如血脂异常、高血压、糖尿病等）应积极治疗。

2.咽炎。建议耳鼻喉科诊治。

3.血脂异常。总胆固醇值偏高(6.03mmol/L)(参考值<5.18)；甘油三酯值偏高(1.86mmol/L)(参考值<1.70)；低密度脂蛋白胆固醇值偏高(3.42mmol/L)(参考值<3.37)；动脉粥样硬化指数提示：动脉硬化指数（AI）值偏高(4.03)(参考值<4.00)。建议控制饮食和健康的生活方式，心内科随诊。
【血脂异常】是一类较常见的疾病，是人体内脂蛋白的代谢异常，主要包括总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯升高和或高密度脂蛋白胆固醇降低等。血脂异常是导致动脉粥样硬化的重要因素之一，是冠心病和缺血性脑卒中的独立危险因素。引起血脂异常的原因：（1）饮食不科学。（2）生活无规律，体力活动减少。（3）患有某些代谢性疾病，如肥胖症、糖尿病、遗传疾病等。健康体检发现血脂异常者应注意：（1）调整膳食结构。（2）加强体育锻炼，控制体重。（3）戒烟，控酒。（4）控制影响血脂的其他疾病，如糖尿病等。（5）对于40岁以上的中老年人群或者血脂异常合并高血压、糖尿病、冠心病等危险因素者，应定期检测相关指标。经上述方法调整仍不理想，建议在医生指导下用药。

4.C13呼气试验(HP)阳性。建议消化内科治疗后复查。
【幽门螺杆菌感染】幽门螺杆菌感染与众多消化系统疾病的发生关系密切，且是预防胃癌最重要且最可控的危险因素，诊断及根除可作为预防胃癌的一级措施。尿素呼气试验是目前临床检测幽门螺杆菌的最常用方法之一。口腔和胃中微生物密度的干扰、上消化道急性出血、胃排空快，服用质子泵抑制剂、铋剂、抗生素等可能会影响检测结果的准确性。当您的检测结果为阳性而DOB值＜6（临界值）时，暂无需抗生素根治治疗，建议间隔5-7天后重新检测（复查）。当DOB值＞6时，建议去医院消化内科就诊，由消化专科医师评估后采取最佳的根治方法。

5.CT提示：左肺上叶微小结节待除外。建议呼吸内科进一步检查。
【肺部结节】肺结节是指肺内生理或病理性组织，在CT或X线胸片上显示为局灶性、类圆形密度增

高的阴影。肺内很多疾病都会形成结节，如炎症、结核、霉菌、出血、肿瘤等。多数肺结节是良性的，部分有恶性风险。肺部结节通常无症状。若首次发现肺部结节，需要医院呼吸专科医生，结合病史、症状及其他相关检查阳性结果等，对肺部结节的性质进行风险评估，并定期复查随访。吸烟者建议戒烟。如您同时伴有咳嗽、咳痰、痰中带血等不适，应及时呼吸内科就诊。

6.CT提示：两侧胸膜局部增厚。建议呼吸内科定期复查。
【胸膜增厚】胸膜是一层浆膜，覆盖于肺表面及胸廓内侧面，分别称为脏层及壁层胸膜，正常胸膜在X线检查时，一般不显影。胸膜病变（胸腔积液、胸膜炎、脓胸、胸膜肿瘤）及陈旧性胸膜改变，在胸部X线、CT检查时，可表现为广泛或局限胸膜增厚、粘连及钙化等。除陈旧性胸膜改变外，胸膜增厚应定期随访；如您有咳嗽、胸闷、胸痛、发热等不适，应及时到医院呼吸内科诊治。

7.超声提示：肝内脂肪浸润。建议消化内科随诊。
【肝内脂肪浸润】肝脏内的脂肪含量增多，脂肪细胞大量充盈于肝细胞内，称肝脂肪浸润。营养不良或体形消瘦者也可导致本病，但肥胖者更易发生。肝内脂肪浸润主要需要注意平时的饮食、生活习惯，做到忌酒、低脂、低盐，富含维生素、纤维素等食物，加强锻炼；营养不良性脂肪肝患者应适当增加营养，尤其高蛋白质和富含维生素食物。肝内脂肪浸润通过控制饮酒、调节饮食、积极锻炼的方法可以恢复。必要时消化内科就诊。

8.超声提示：胆囊壁稍毛糙。建议肝胆外科随诊。

主检医师：张茜　初审医师：宋惠玲

成都高新瑞慈瑞高体检门诊部

终审日期：2026-04-02 13:58:51　初审日期：2026-04-02 09:04:19

报告解读

体检报告解读方式：

（1）现场咨询：到体检机构客服部当面咨询。

（2）电话咨询：按体检报告底部右下方显示电话号码致电体检机构咨询。

（3）致电瑞慈服务热线4001688188转接预约咨询。

（4）微信小程序在线解读报告:扫一扫右侧小程序二维码，在线解读报告。

备注：具体咨询时间以体检机构告知为准；由于体检业务繁忙，高峰时段，可能会有医生无法立即接待、座机无法及时接听的情况，敬请客户谅解。

微信扫一扫，解读报告

电话:028-67568096